

• 调查报告 •

中毒损伤程度法医临床鉴定分析

谭文帅¹, 刘佳琪¹, 高香亭^{1,2}, 陈晨¹, 袁宇浩¹, 余仲昊¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430000; 2. 石河子大学医学院, 新疆 石河子 832003)

【摘要】中毒损伤在法医临床鉴定中发生率相对较低,但在案件定性、责任认定及司法裁判中具有重要意义。然而,目前关于中毒损伤程度的法医临床鉴定标准及相关研究仍较为匮乏。本文系统回顾了 2000—2025 年间我国关于中毒损伤程度法医临床鉴定的相关文献,对毒物种类、临床表现、损伤程度分级的主要依据进行筛选及分析。共统计符合分析筛选标准的中毒损伤程度鉴定案例 359 例,结果显示,案件主要为香豆素类抗凝血杀鼠剂中毒(170 例)、毒鼠强中毒(94 例)、亚硝酸盐中毒(84 例);各种毒物造成的临床表现存在明显差异,现行损伤程度鉴定标准在中毒法医临床鉴定的适用性存在不足。因此,作者建议在中毒损伤程度鉴定中应充分利用临床资料、将毒物浓度或其他量化指标引入中毒损伤程度鉴定,在未来鉴定标准中增加中毒损伤条款。

【关键词】法医临床学;法医毒物学;损伤程度;司法鉴定;中毒

【中图分类号】D919.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2026)03-0342-06

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2026.03.014

Forensic clinical assessment and recommendations on the degree of poisoning injuries. Tan Wenshuai¹, Liu Jiaqi¹, Gao Xiangting^{1,2}, Chen Chen¹, Yuan Yuhao¹, Yu Zhonghao¹, Zhou Yiwu¹ (1. The Department of Forensic Medicine of Tongji Medical College, Wuhan, Hubei 430000, China; 2. Shihezi University School of Medicine, Shihezi, Xinjiang 832003)

【Abstract】Poisoning-induced injuries have a relatively low incidence in forensic clinical assessments, yet they play a vital role in case characterization, liability determination, and judicial adjudication. However, current research and standards for forensic clinical assessment of the degree of poisoning injury are still scarce. This article systematically reviews relevant literature on forensic clinical assessment of the degree of poisoning injury published in China from 2000 to 2025, screening and analyzing the main criteria for classifying the types of poisons, clinical manifestations, and severity of injury. A total of 359 cases meeting the analysis criteria were analyzed. The results show that the main types of cases were coumarin anticoagulant rodenticide poisoning (170 cases), tetramine poisoning (94 cases), and nitrite poisoning (84 cases). Significant differences exist in the clinical manifestations caused by various poisons, and the current standards for assessing the degree of injury are insufficient for the applicability of forensic clinical assessments of poisoning. Therefore, the authors suggest that clinical data should be fully utilized in assessing the degree of poisoning injury, that poison concentration or other quantitative indicators should be introduced into the assessment, and that a clause on poisoning injury should be added to future assessment standards.

【Key words】Clinical forensic medicine; Forensic toxicology; Degree of injury; Forensic identification; Poisoning

目前的法医临床鉴定主要是依据现行《人体损伤程度鉴定标准》(司发通[2013]146号)进行,该标准侧重于可客观观察和测量的器质性损伤,相关评定体系亦主要围绕器质性损伤后果建立。机械性损伤多表现为明确的器质性损害,现行损伤程度鉴

定标准对其具有较好的适用性。

然而,中毒作为一种化学性损伤,不同毒物在毒性强度、损害后果方面存在显著差异。目前,中毒损伤程度评定主要是比照现行附则条款:“未列入本标准中的物理性、化学性和生物性等致伤因素造成的人体损伤,比照本标准中的相应条款综合鉴定”。虽然部分毒物可引起明确的器质性损伤,但多数毒物中毒仅造成一过性功能损害,往往不遗留可量化的器质性损伤。上述特点使现行损伤程度鉴定标准在中毒性损伤评定中适用性有限。因此,中毒损伤程度鉴定仍是法医临床鉴定实践中的难点之一。

【作者简介】谭文帅,男,硕士研究生,研究方向:法医病理学。

刘佳琪,男,博士研究生,研究方向:法医病理学。

谭文帅、刘佳琪同为第一作者。

【通信作者】周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学研究、鉴定及教学。

本研究采用回顾性研究方法，对 2000 — 2025 年公开发表的中毒损伤法医鉴定案例进行整理，提取中毒类型、临床表现、鉴定意见等信息进行统计和分析，并提出相应的改进建议，以期为法医临床鉴定实践提供参考。

1 方法

通过文献检索收集并筛选中国有关毒物中毒损伤程度的案例信息，使用检索式：“主题：(法医 * 中毒 * (损伤程度 + 鉴定))”，在中国国家知识基础设施工程 (CNKI) 搜索；使用检索式：“主题：(法医临床 AND 中毒 AND (损伤程度 OR 鉴定))” 在万方数据平台检索，收集 2000 — 2025 年各种毒 (药) 物中毒损伤程度鉴定的研究报道；仅纳入正式发表的同行评议期刊论文，排除会议论文、会议摘要及未正式发表的研究报告；排除中毒死亡的案例以及缺乏中毒者临床表现、鉴定依据等关键信息的文献或损伤程度鉴定存在争议的文献；随后，对毒物类型进行整理统计，排除毒物报道少于两篇的毒物文献，最终共获得 18 篇中毒损伤程度法医鉴定文献。在上述中文数据库检索基础上，进一步对 PubMed 和 Web of Science 数据库进行补充检索，时间范围设定为 2000 — 2025 年。英文检索式如下：(poisoning OR intoxication OR "toxic exposure") AND (forensic OR "forensic medicine" OR medico-legal) AND ("severity assessment" OR "poisoning severity score" OR "clinical evaluation" OR "organ damage") AND (patient OR patients OR survivor* OR "non-fatal")。鉴于国外未建立与我国“轻微伤—轻伤—重伤”相对应的统一损伤程度分级鉴定体系，相关研究多集中于中毒严重程度量化评估及法医学实践。因此，本文收集的英文文献主要作为补充资料，用于完善研究背景与讨论分析 (图 1)。

2 结果

2.1 案例信息

纳入 2000 — 2025 年毒物中毒损伤程度鉴定的相关研究报道，共统计 359 例中毒损伤程度法医临床鉴定案例，其中香豆素类抗凝血杀鼠剂中毒 170 例 (47.35 %)、毒鼠强中毒 94 例 (26.18 %)、亚硝酸盐中毒 84 例 (23.40 %)，三者合计占 96.94 %，其余毒物 (汞、有机磷、铊) 共计 11 例 (3.06 %)。依据中毒的毒物种类、数量、性别、损伤程度、属于功能性损伤或器质性损伤等信息归类，将案例信息汇总于下表 (表 1)。

从损伤程度分布看，香豆素类抗凝血杀鼠剂中毒以轻微伤为主 (133/170, 78.24 %)；毒鼠强导致的中毒，重伤所占比例最高 (11/94, 11.70 %)；亚硝酸盐造成的中毒，轻伤所占比例最高 (46/84, 52.87 %)。为直观展示不同毒物中毒损伤程度及损伤性质的分布特征，基于表 1 数据绘制报道案例现

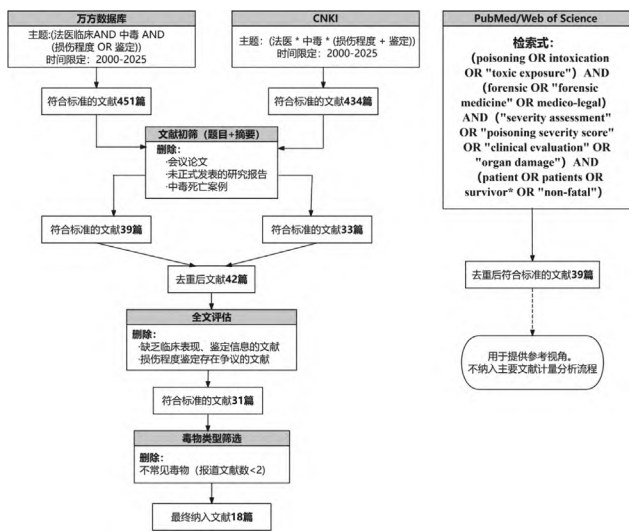


图 1 文献筛选流程图

表 1 2000 — 2025 年 359 例中毒损伤程度鉴定案例信息汇总

毒物种类	例数	文献数	男性	轻微伤	轻伤	重伤	功能性损伤	器质性损伤
香豆素类抗凝血杀鼠剂 ^[1-5]	170	5	--	133	35	2	168	2
毒鼠强 ^[6-10]	94	5	--	70	13	11	94	0
亚硝酸盐 ^[11, 12]	84*	2	--	37	46	1	84	0
汞 ^[13, 14]	5	2	2	0	5	0	4	1
有机磷 ^[15, 16]	4	2	2	0	2	2	3	1
铊 ^[17, 18]	2	2	2	1	1	0	2	0
总计	359	18	83	241	102	16	355	4

*: 亚硝酸盐中毒案例中 3 人被认定为未达轻微伤，不计入总案例数；-- 代表缺少具体信息

表 2 中毒者临床表现汇总

系统受累情况	香豆素类抗凝血 杀鼠剂 ^[1-5]	毒鼠强 ^[6-10]	亚硝酸盐 ^[11, 12]	汞 ^[13, 14]	有机磷 ^[15, 16]	铊 ^[17, 18]	合计
凝血功能损害							
(出血、瘀斑、PT/APTT 延长)	170	0	0	0	0	0	170
神经系统功能损害							
(昏迷、手指麻木、抽搐、肌力下降)	1	34	6	0	4	2	47
循环功能损害							
(心律失常、心肌损伤、休克等)	13	41	4	0	1	0	59
氧合功能							
(发绀, 皮肤黏膜青紫等)	0	0	54	0	0	0	54
肾功能损害							
(尿素氮 / 肌酐异常、肾病综合征等)	11	3	0	5	0	0	19
肝功能损害 (ALT/AST 升高等)	11	6	2	0	0	1	20
呼吸功能损害							
(呼吸急促、呼吸抑制等)	1	5	0	0	2	0	8

注：系统受累情况依据病例报道中的临床表现及实验室检查结果进行归类统计，同一病例可同时存在多个系统受累

多的前 3 种毒物（香豆素类抗凝血杀鼠剂、毒鼠强、亚硝酸盐，共 351 例）的中毒损伤程度分布的堆积柱形图（图 2）。

此外，从损伤性质上看，多数中毒病例表现为功能性损伤（355/359，98.89 %），器质性损伤较少见（4/359，1.11 %）。

2.2 中毒临床表现

为减少不同毒物临床表现的异质性和对统计分析的影响，本研究依据法医临床鉴定中损伤程度评定的关注重点，将各类中毒的具体临床表现和辅助检查结果统一归类为不同功能系统受累情况进行统计分析。

结果显示，不同毒物主要受累系统存在差异：香豆素类抗凝血杀鼠剂中毒主要表现为凝血功能损害（170 例）；毒鼠强中毒以神经系统及循环系统功能损害为主（分别为 34 例和 41 例）；亚硝酸盐中毒主要表现为氧合功能障碍（54 例）。此外，部分病例可累及肝功能（20 例）、肾功能（19 例）及心肌损伤等。总体来看，同一毒物中毒可累及多个系统，不同毒物之间受累系统分布存在差异（表 2）。

2.3 鉴定依据统计

为评估收集到文献的鉴定可靠性，对出现急性功能障碍或器质性损伤的被鉴定人的评定依据（16 篇^[1-12, 15-18]，共 232 例）进行整理和分层分析（表 3）。结果显示：在量化指标应用方面，尚无研究采

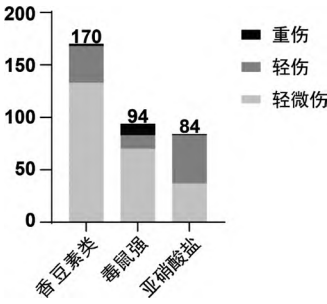


图 2 3 类毒物中毒损伤程度分布堆积柱形图

表 3 16 篇中毒损伤程度法医鉴定文献评定依据统计汇总

项目	分类	文献数	案例数
量化指标	毒物剂量评定损伤程度	0	0
	其他量化指标评定损伤程度	5	81
	未使用量化指标 / 量化指标仅用于定性	11	151
临床表现	急性期症状	10	167
	后遗症状（1 月内）	2*	4
	后遗症状（超过 3 个月）	2	2
	未明确	3	59
医疗因素	接受医疗	16	232
	未考虑医疗因素	16	232
	医疗使症状缓解	16	222

*：其中 1 篇文献分别使用急性期症状和后遗症状对不同被鉴定人进行损伤程度评定

用毒物剂量作为损伤程度评定依据;5 篇文献(81 例)采用其他量化指标参与评定,其余 11 篇文献(151 例)未使用量化指标或仅用于定性分析。在临床表现依据方面,10 篇文献(167 例)采用急性期症状作为评定依据,2 篇文献(共 6 例)采用后遗症症状作为依据,3 篇文献(59 例)未明确说明评定依据。在医疗因素方面,全部病例均接受不同程度医疗干预,其中 222 例(95.69%)在治疗后症状有所缓解。

3 讨论

3.1 中毒损伤程度鉴定的现状及存在问题

本研究收集并整理了 2000 年之后中毒损伤程度鉴定文献,对中毒损伤鉴定体现状和不同毒物造成的损伤程度进行分析及汇总,共纳入 359 例中毒案例,统计结果提示当前中毒损伤程度鉴定仍存在一些问題。

(1) 中毒损伤具有毒物类型集中但损伤表现异质性强特点,不同毒物在毒理机制、靶器官及损伤转归方面存在显著差异。收集到的文献中,香豆素类抗凝血杀鼠剂、毒鼠强及亚硝酸盐中毒案例比例达 96.94%,且 3 种毒物所致损伤程度分布存在明显差异。毒鼠强中毒重伤比例相对较高,亚硝酸盐中毒以轻伤为主,而香豆素类抗凝血杀鼠剂中毒以轻微伤为主。因此,现行以器质性损伤后果为核心的《人体损伤程度鉴定标准》在中毒损伤评定中的适用性存在局限,难以全面反映不同毒物所致损伤的实际严重程度。

(2) 中毒损伤呈现“以功能性损伤为主、部分伴随器质性损伤”的双重特征。一方面,多数中毒患者在急性期表现为明显功能障碍,但经治疗后可恢复,缺乏稳定的器质性损害;另一方面,部分病例仍可出现肝功能损害、肾功能异常或心肌损伤等器质性改变。既往鉴定实践中更侧重于是否留有后遗症,可能导致对急性期严重功能障碍或短暂器质性损伤的低估。因此,中毒损伤程度评定不宜单纯依赖最终转归,而应综合考虑急性损伤程度、器质性损害及其动态变化过程。

(3) 现有文献中 68.75% 的案例未采用毒物浓度或其他客观量化指标进行损伤评定;不同研究在鉴定时限(急性期或后遗症期)及依据选择上存在明显差异,且医疗因素未被纳入评估,而绝大多数患者经治疗后症状明显缓解,可能对最终鉴定意见产生重要影响。

3.2 国际中毒损伤程度评估研究现状及启示

从国际研究现状来看,国外未建立类似我国“轻

微伤—轻伤—重伤”的统一法医学损伤程度分级体系,尤其在中毒相关损伤评定方面,更缺乏直接对应的法律化分级标准。现有研究主要集中于临床毒理学和法医学交叉领域,侧重通过客观指标对中毒严重程度进行量化评估,而非固定的等级划分^[19-21]。

在具体方法上,国外多采用中毒严重程度评分系统对活体患者进行评价,如 Poisoning Severity Score (PSS)、APACHE II 评分及 Glasgow 昏迷评分(GCS)等^[21]。这类指标主要基于患者的临床表现、生理参数及器官功能损害程度,对中毒的严重性及预后进行综合判断。

与之相比,我国现行损伤程度评定体系具有显著的制度化和标准化特点,通过明确的分级标准(如轻微伤、轻伤、重伤),可直接应用于刑事司法实践,在案件定性与量刑中发挥关键作用。然而,在中毒损伤领域,该体系仍面临一定局限,例如上述的对中毒复杂病理过程的反映不足、对动态变化的考虑不充分、量化指标相对缺乏等问题。

基于上述分析,国外相关研究对我国具有以下启示:首先,可借鉴其中毒严重程度评分系统,引入客观量化指标,以提高损伤评定的科学性和一致性;其次,应加强对功能损害及预后因素的综合评价,避免单一静态指标对复杂中毒损伤的简化;最后,可在保持现有法律分级体系的基础上,探索建立“分级+量化指标”相结合的评定模式,从而更全面、准确地反映中毒损伤的实际程度。

3.3 中毒损伤程度鉴定改进建议

针对国内中毒损伤程度鉴定难题及研究现状^[22],我们对中毒损伤程度鉴定提出以下建议性方案。

(1) 针对常见毒物建立分类型鉴定标准:目前绝大多数案例集中于少数毒物(香豆素类抗凝血杀鼠剂、毒鼠强、亚硝酸盐),且不同毒物损伤模式差异显著,建议优先针对上述常见毒物,分别建立细化的损伤程度鉴定标准,以提高鉴定的针对性和可操作性。

(2) 引入毒物中毒血浓度及客观量化指标作为损伤程度鉴定依据:本研究收集的案例中,大部分案例缺乏量化指标,鉴定具有一定主观性。目前《中华人民共和国国家职业卫生标准》^[23]《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》^[24]《急性中毒诊断与治疗中国专家共识》^[25]等中毒相关分级标准,建立了毒物中毒细化分级依据,可将其作为辅助鉴定依据。以亚硝酸盐中毒为例^[11],临床上将血液中亚硝酸盐含量作为亚硝酸盐中毒分级的重要指标,鉴定人参照临床标准对其进行鉴定。此外,针对难以

获得中毒急性期毒物浓度的难题,建议加强与临床领域的研究合作,在临床治疗中面对中毒患者时,常规对血液、毛发等检材进行留存,推进中毒损伤程度法医鉴定量化和规范化,增强鉴定意见的科学性;同时结合不同毒物特点,探索高铁血红蛋白、胆碱酯酶活性、凝血功能指标等客观指标在损伤评定中的应用,以增强鉴定的客观性。

(3) 引入毒物中毒重要生命指标和重要器官损伤功能损害程度作为鉴定依据:如毒鼠强中毒导致昏迷、呼吸衰竭可评定为重伤;根据毒鼠强中毒后心肌酶、脑电图最严重时进行损害程度评定等。

(4) 完善并细化毒物中毒损伤程度鉴定标准,构建功能损伤—器质性损伤综合评定模式:针对毒物引起的中毒者器质性和功能性损伤做出更细致的规定,明确常见毒物一过性损伤和迟发性损伤的鉴定要点,建议在鉴定中同时关注急性期功能障碍、器质性损害及其转归,而非单纯依据后遗症进行评定,从而避免对急性严重损伤的低估。

(5) 将医疗干预因素纳入鉴定依据。建议在鉴定过程中结合就医时间、治疗措施及疗效,对损伤程度进行动态评估,以避免因医疗条件差异导致评定偏差。

3.4 研究局限性

需要说明的是,本研究仍存在一定局限性。首先,本研究主要基于已发表文献进行分析,可能受到发表偏倚的影响,部分未发表或未被收录的相关案例未能纳入分析范围;其次,纳入文献数量总体较少,且病例来源以个案报道或小样本研究为主,不同研究之间在资料完整性、鉴定依据及报告质量方面存在差异,可能对结果的稳定性产生一定影响;此外,在毒物类型分析过程中,本研究排除了报道文献少于2篇的毒物类型,主要基于统计分析稳定性及结果可比性的考虑,以避免单一或个别病例对整体分析结果造成过度影响;然而,该纳入标准亦可能导致部分少见毒物相关的重要信息被忽略,从而引入一定的选择性偏倚,对中毒损伤类型的全面反映存在一定局限;再次,本研究纳入文献中部分案例缺乏统一的客观量化指标,不同研究在损伤程度评定时限及依据选择方面存在差异,可能影响结果的可比性与一致性。同时,由于中毒损伤具有明显的动态变化特点,而多数文献为回顾性分析,难以全面反映损伤发展的全过程;最后,本研究以我国现行中毒损伤程度鉴定体系为主要研究对象,尽管补充检索了国际数据库文献,但国外尚缺乏与我国相对应的统一分级体系,相关文献主要用于讨论参考,

未纳入系统分析范围,因此在国际比较方面仍存在一定局限。

综上,未来研究可通过扩大样本来源、开展多中心研究、引入统一量化指标及加强国际研究对比等方式,以进一步提升研究结论的可靠性与外推性。

参考文献

- [1] 杜新增,张鑫,姜绍娥,等.一起溴敌隆群体中毒的法医临床学分析[J].中国法医学杂志,2003,18(1):34-35.
- [2] 黄荣发.溴敌隆中毒损伤程度鉴定1例[J].法医学杂志,2013,29(2):154.
- [3] 黄若予,王志永,庞秋愉,等.多次投毒溴敌隆致1死1伤的法医学鉴定[J].法医学杂志,2025,41(2):176-180.
- [4] 刘淑芳,刘明树,黄映雪.溴敌隆中毒后损伤程度评定分析14例[J].中国法医学杂志,2014,29(2):152-153.
- [5] 王小伟,夏鹏,李红卫.香豆素类抗凝血杀鼠剂投毒法医学鉴定分析[J].中国法医学杂志,2018,33(2):187-189,193.
- [6] 李金菊,颜意诚.毒鼠强中毒损伤程度法医学鉴定分析1例[J].中国法医学杂志,2024,39(S1):S79.
- [7] 潘卫军,陈晓锋,胡建光,等.1例儿童毒鼠强中毒的法医学鉴定[J].复旦学报(医学版),2017,44(S1):S86,S88.
- [8] 唐云莉,许冰莹,严红涛.78例毒鼠强中毒案例损伤程度的法医学鉴定[J].昆明医学院学报,2004,25(4):76-79.
- [9] 魏春梅,姜奎益,夏辉,等.13例毒鼠强中毒及其损伤程度评定[J].刑事技术,2009(5):55-56.
- [10] 徐尚贵,王和清.毒鼠强中毒的损伤程度鉴定1例[J].中国法医学杂志,2005,20(1):50.
- [11] 莫李红,廖明庆,朱豪.41例亚硝酸盐中毒损伤程度评定分析[J].广东公安科技,2023,31(1):74-75.
- [12] 许正荣,陈越青.46例急性亚硝酸盐中毒分析[J].中国法医学杂志,2012,27(S1):S69-S70.
- [13] 沈凯.伪劣化妆品致肾功能损害法医学鉴定1例[J].中国法医学杂志,2024,39(S1):S91-S92.
- [14] 黄卫巍,刘敏,刘晓维.化妆品汞超标致人身损害法医临床鉴定分析[J].中国司法鉴定,2023(1):93-96.
- [15] 马静媛,荆小莉,马军,等.非法行医致伤法医学鉴定2例[J].法医学杂志,2014,30(5):401-402.
- [16] 王新平,阚卫军,陈小坤.有机磷农药中毒损伤程度鉴定3例[J].中国法医学杂志,2009,24(4):279.
- [17] 陈霞,曹正军.铊中毒致轻伤法医学鉴定1例[J].中国法医学杂志,2014,29(2):170-171.
- [18] 徐飞,孙凤莲,韩小勇.急性铊中毒致重伤法医学鉴定1例[C]//法医临床学专业理论与实践——中国法医学学会·全国第二十一届法医临床学学术研讨会,贵

(下转第351页)

难以对被鉴定人王某 2020 年 5 月时的精神状态作出精神疾病分类学诊断。

(2) 民事行为能力评定: 据目前材料, 难以对被鉴定人王某 2020 年 5 月时的精神状态作出精神疾病分类学诊断。据被鉴定人 2020 年 5 月 27 日订立代书遗嘱时的影像材料显示, 当时王某意识清楚, 接触较被动, 问话可答, 语量少, 语速较慢, 回答简单。综合上述情况, 参照《精神障碍者民事行为能力评定指南》(SF/Z JD0104004-2018) 之规定, 目前无法对被鉴定人王某 2020 年 5 月 27 日订立代书遗嘱时的民事行为能力进行评定。

鉴定意见: 据目前材料, 难以对被鉴定人王某 2020 年 5 月时的精神状态作出精神疾病分类学的诊断, 对被鉴定人王某 2020 年 5 月 27 日订立代书遗嘱时的民事行为能力无法进行评定。

评析: 本例中, 鉴定意见的得出与鉴定材料是否充分、真实密切相关。在对王某进行医学诊断时, 病历材料比较充分、连贯, 但相关病历并不是精神专科医院的记录和描述, 且病历中对其有无精神异常的记录情况不一。虽曾诊断其“多发性脑梗死、阿尔茨海默病、精神障碍”, 但也有病历记录其“神志清楚, 言语流利, 理解力、判断力、定向力正常, 记忆力正常, 计算力正常”。鉴于王某在鉴定时已经死亡, 故据上述材料不能对其立遗嘱时所患精神疾病作出疾病分类学诊断。

在评定王某的民事行为能力时, 直接证据材料为当时的视频材料。据订立遗嘱时的影像材料显示,

当时王某意识清楚, 接触较被动, 问话可答, 语量少, 语速较慢, 回答简单。根据民事行为能力评定的足够能力原则, 上述材料不能证明其立遗嘱时不能理解相关情况和无法作出真实的意思表示。结合不能对王某所患精神疾病作出明确诊断这一情况, 故得出了无法对其 2020 年 5 月 27 日订立代书遗嘱时的民事行为能力进行评定的鉴定意见。

在进行既往民事行为能力鉴定时, 因鉴定材料的有限性、鉴定的回顾性, 鉴定人作出明确精神医学诊断、民事行为能力评定存在较大困难, 应在鉴定前充分认识、评估, 将鉴定风险告知委托方及当事人, 在条件允许的情况下尽量得出合理、客观的鉴定意见, 以达到更好地为司法审判服务的目的。

参考文献

- [1] 罗小年. 民事行为能力鉴定的几个问题—读者来信 [J]. 临床精神医学杂志, 2013, 23(3): 215-216.
- [2] 汤涛, 刘超. 既往借贷行为民事行为能力鉴定 1 例 [J]. 中国司法鉴定, 2021(3): 107-109.
- [3] 曹威, 刘小林. 197 例民事行为能力的司法精神病学鉴定分析 [J]. 临床精神医学杂志, 2007, 17(6): 404-406.
- [4] 铁常乐, 张琳, 黄青. 死者生前司法精神病鉴定 22 例分析 [J]. 中国法医学杂志, 2017, 32(S1): S11-S13.
- [5] 张钦廷, 庞艳霞, 蔡伟雄, 等. 精神障碍者民事行为能力评定量表研制 [J]. 法医学杂志, 2010, 26(5): 353-356.

(收稿日期: 2025-10-21)

(上接第 346 页)

阳, 2018.

- [19] Abdel-Ghaffar Abdel-Dayem R S, Elshama S S, Maklad A I, et al. Assessment of the pattern, severity, and outcomes of acute mood stabilizer drug poisoning[J]. Toxicol Res (Camb), 2024, 13(6): tfae193.
- [20] Conner K R, Wiegand T J, Gorodetsky R, et al. Validation of the Poisoning Severity Score (PSS) in suicidal behavior by self-poisoning[J]. Behav Sci Law, 2019, 37(3): 240-246.
- [21] Sam K G, Kondabolu K, Pati D, et al. Poisoning severity score, APACHE II and GCS: effective clinical indices for estimating severity and predicting outcome of acute

organophosphorus and carbamate poisoning[J]. J Forensic Leg Med, 2009, 16(5): 239-247.

- [22] 周亦武, 刘良. 法医学中毒鉴定的挑战与展望 [J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 107-110.
- [23] GBZ/T 229.1—2025 中华人民共和国国家职业卫生标准 [S].
- [24] GB/T 16180—2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级 [S].
- [25] 宋维, 李超乾, 田英平, 等. 急性中毒诊断与治疗中国专家共识 [J]. 中国急救医学, 2016, 36(11): 961-974.

(收稿日期: 2026-01-31)